ONEMA-POP-019 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

1

ONEMA-POP-019 — Manejo de Tecidos Inviáveis (Esfacelo e

Necrose) e Segurança na Indicação de Desbridamento

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-019 | Manejo de Tecidos Inviáveis (Esfacelo e Necrose) e Segurança na Indicação de

REVISÃO

2. Objetivo e abrangência

Identificar tecidos inviáveis e definir segurança e necessidade de avaliação especializada para desbridamento.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento e atuação dentro das competências profissionais. Feridas com esfacelo, escara ou necrose; não autoriza desbridamento instrumental sem competência, avaliação vascular, indicação e protocolo específicos.

4. Materiais, equipamentos e responsável pelo fornecimento

Paciente: materiais de curativo e limpeza pactuados; enfermeiro: EPI, iluminação, régua, material de documentação; instrumentais apenas quando houver indicação e autorização institucional. Fornecimento pactuado no pedido e confirmado antes da visita.

5. Avaliação clínica e preparação

Determinar etiologia, perfusão/pulsos e sinais de isquemia, diabetes, dor, profundidade, extensão da necrose, odor, exsudato, anticoagulação e risco de sangramento.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar identidade, consentimento, histórico vascular e condições sistêmicas.

2. Inspecionar e descrever esfacelo (tecido desvitalizado úmido) versus escara (tecido necrótico mais seco/aderido), sem

confundir com fibrina viável.

3. Avaliar perfusão e sinais de isquemia antes de qualquer decisão de remoção; buscar avaliação vascular quando

comprometida.

4. Investigar infecção, celulite, crepitação, dor desproporcional e comprometimento profundo.

5. Não remover escara seca, aderida e estável em calcâneo isquêmico sem avaliação especializada e indicação formal.

6. Selecionar apenas medidas conservadoras previstas no plano e compatíveis com perfusão, infecção e instruções de

produto.

7. Não executar desbridamento cortante ou profundo como ato automático; exigir competência, indicação, consentimento

e recursos para hemostasia.

8. Encaminhar para estomaterapia/equipe médica/vascular quando necrose extensa, etiologia incerta ou necessidade de

intervenção avançada.

9. Documentar tipo/percentual aproximado de tecido, área, decisão de não desbridar e encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Gangrena úmida, crepitação, progressão rápida, febre ou instabilidade, isquemia aguda ou sangramento: emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar não remover escaras em casa, proteger área e retornar diante de odor progressivo, secreção, dor ou alteração de cor.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação e consentimento; avaliação inicial e sinais vitais quando indicados; descrição objetiva, classificação/medidas,

intervenção, insumos, resposta, intercorrências, orientações, comunicação e plano de seguimento; assinatura profissional

2

e trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

NICE — Pressure ulcers CG179 — https://www.nice.org.uk/guidance/cg179

IWGDF/IDSA — Diabetic Foot Infections 2023 — https://www.idsociety.org/practice-guideline/diabetic-foot-infections/